การบริการทางการแพทย์ ระดับหน่วย

พ.อ.ประจวบ วันตา
อจ.หน.รร.สร.พบ.

ขอบเขตการสอน/ เอกสารอ้างอิง

กองทัพบก

คู่มือราชการสนาม

ว่าด้วย

หลักนิยมการบริการทางการแพทย์

พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ 2 การบริการแพทย์เขตยุทธบริเวณ

2.1 หมวดเสนารักษ์และการบริการแพทย์ระดับหน่วย

คู่มือราชการสนาม

ว่าด้วย

หลักนิยม ว่าด้วยการบริการทางการแพทย์

พ.ศ.2562

คลังตำรา ร.ส.ร.พ.

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การบริการทางการแพทย์
ในสนาม(สงคราม)

เขตสงคราม

เขตภายใน

5. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตภายใน

รพ.ทบ. (นขต.พบ.)
- รพ.รร.6
- รพ.อ.ป.ร.
- รพ.ค่ายสุรนารี
- รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ทร.
- รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ทอ.
- รพ.องค์การทหารผ่านศึก
- รพ.พลเรือนที่กำหนด

เฉพาะทาง พักฟื้น อวัยวะเทียม

เขตยุทธบริเวณ

เขตหลัง

4. การบริการทางการแพทย์ระดับเขตหลัง

รพ.มทบ./รพ.พลเรือนในพื้นที่

เฉพาะทาง

เขตหน้า

1. การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย
ขนาดหน่วยตั้งแต่ มว.สร. ลงมา
ฉุกเฉิน TCCC

2. การบริการทางการแพทย์ระดับกองพล
พัน.สร.พล ช่วยชีวิตขั้นแรก

3. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค
พัน.สร.บชร. รักษาช่วยชีวิต

การบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธี

การบริการทางการแพทย์ ระดับหน่วย

การบริการทางการแพทย์ ในสนาม(สงคราม)

ลำดับการรักษาพยาบาลและการส่งกลับในสนาม ทบ.

4-5

เขตหลัง/ภายใน

ที่เฉพาะ/พักฟื้น

18 คัน

มว.รยพ.

30 วัน

พัน.สร.บชร.

ช่วยชีวิต

ร้อย.สร.สน.

ชุดศัลยกรรมสนาม

ชุดรักษาพยาบาล

3.ระดับ ทภ.

เร่งด่วน

มว.สร.

ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนส่งกลับ

3 คัน

10 คัน

20 วัน

ร้อย.สร.

ช่วยชีวิตขั้นแรก

พัน.สร.

กรม สน.พล.ร.

2.ระดับกองพล

TCCC พบ.

ช่วยเหลือตนเอง

SELF AID

ช่วยเหลือโดยเพื่อน

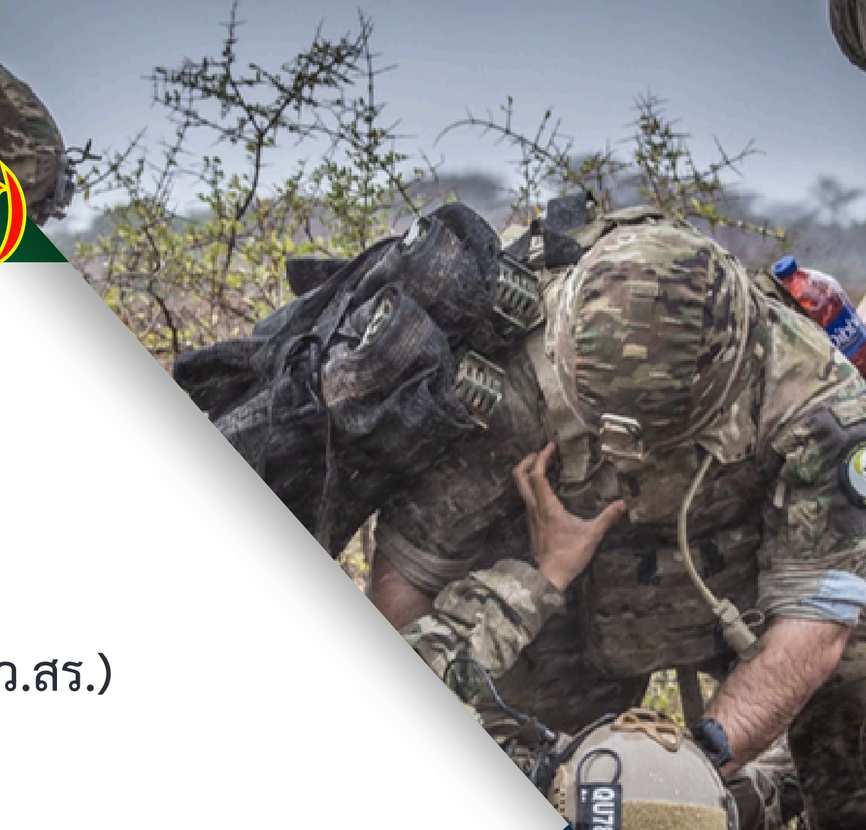
BUDDY AID

ส.พยาบาลกองร้อย

AID MAN

ลาก/ อุ้ม/ เปล

1.ระดับหน่วย



ลักษณะทั่วไป

1. หน่วยสายแพทย์ใน อจย.

- อยู่ในอัตราการจัดของ หน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบ
- เป็นหน่วยที่มีขนาด ตั้งแต่ มว.สร. ลงมา (หมู่ สร., ตอน สร., มว.สร.)

2. ขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์จำกัด

- ความคล่องตัวสูง การรักษาไม่สมบูรณ์
- ใช้วิธีรักษาช่วยชีวิตเร่งด่วนเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการรักษาที่สมบูรณ์

- หน่วยกำลังรบ เหล่า ร. ม. รพศ.
- หน่วยสนับสนุนการรบ เหล่า ป.,ช., สส.,วศ., หน่วยบิน ทบ.

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การบริการทางการแพทย์
ในสนาม(สงคราม)

ลักษณะทั่วไป
การบริการทางการแพทย์

ใช้หลักการดูแลผู้ป่วยเจ็บเชิงยุทธวิธี
(Tactical Combat Cascualty Care:TCCC)

โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ

1. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเสียชีวิตที่ป้องกันได้
2. ป้องกันไม่ให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม
3. ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง

M-A-R-C-H P-A-W-S (Pain)

คู่มือสอน TCCC
คป.ว่าด้วยคู่มือ ส.พยาบาลกองร้อย

การบริการทางการแพทย์
ในสนาม(สงคราม)

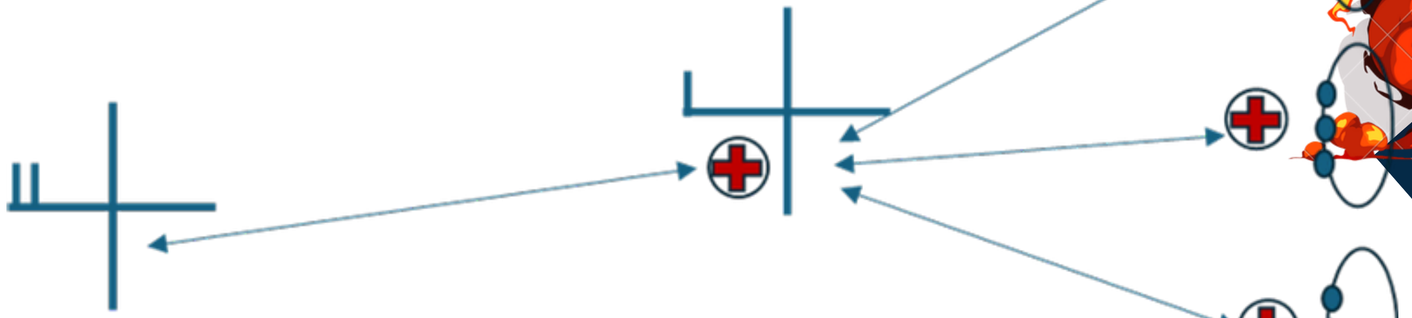
การบริการทางการแพทย์
หน้าที่ นอกสถานการณ์รบ

1. เปิดที่ตรวจโรค ตามความจำเป็น
2. ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการเวชกรรมป้องกัน ด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต การควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันแมลงและสัตว์กัดแทะ
3. ฝึกสอนกำลังพลของ พัน.ร. เรื่องการปฐมพยาบาล TCCC สุขศาสตร์ส่วนบุคคล และการเวชกรรมป้องกัน

การบริการทางการแพทย์
หน้าที่ ในสถานการณ์รบ

มีงานเพิ่มจากงานนอกสถานการณ์รบ คือ

1. จัดนายสิบพยาบาลกองร้อย ไปสมทบหน่วยรบตามอัตรามูลฐาน 4 นาย ต่อ 1 ร้อย.อวบ.(1 นาย ต่อ 1 มว.ปล. และอีก 1 นาย ที่ ทก.ร้อย.อวบ.) หรือตามความจำเป็น
2. จัดตั้งที่พยาบาลกองพันทำการคัดแยกผู้ป่วยเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเพิ่มเติมต่อจากนายสิบพยาบาลกองร้อย



การบริการทางการแพทย์
ในสนาม(สงคราม)

การบริการทางการแพทย์

หน้าที่ ในสถานการณ์รบ

3. ทำการส่งกลับ ผป.เจ็บจากสนามรบ มายังที่พยาบาลกองพันและประสานการส่งกลับไปยังที่พยาบาลกองพล

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเวชกรรมป้องกัน

ให้บริการทางการแพทย์ทางท้ายรถ(Tailgate Medical Service) เมื่อหน่วยดำเนินกลยุทธเคลื่อนที่เร็ว

ประเภทหน่วย พล.ร.ทบ.ไทย 10 พล.ร.

ตอนที่ ๑ : กล่าวทั่วไป

ตอนที่ ๒ : กองพลทหารราบ

พล.1 รอ., พล.ร.3, 4, 5, 6 และ 11

พล.ร. (มาตรฐาน)

ในตอนนี้จะกล่าวถึงกองพลทหารราบมาตรฐานทั่วๆ ไปซึ่งมีรูปแบบการจัดตามที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์, กองพลทหารราบที่ ๓, ๔, ๕, ๖,๑๑ เป็นต้น คำย่อที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้จะใช้คำว่า "พล.ร."

ตอนที่ ๓ : กองพลทหารราบยานเกราะ พล.ร.2 รอ.

พล.ร..ยก.

เป็นรูปแบบการจัดกองพลทหารราบ เพื่อให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติการรุกได้อย่างทันที สอดคล้องกับรูปแบบของสงครามในอนาคต รวมทั้งสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีด้วย ปัจจุบันหน่วยที่มีรูปแบบการจัดคือ พล.ร.๒ รอ. คำย่อที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้จะใช้คำว่า "พล.ร.ยก."

ตอนที่ ๔ : กองพลทหารราบยานยนต์

เป็นรูปแบบการจัดกองพลทหาร[illegible]อนาคต มุ่งหมายที่จะจัดให้เป็น พล.ร.มาตรฐาน ที่มีขีดความสามารถในการ เข้าตี ตั้งรับ และเคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำย่อที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้จะใช้คำว่า "พล.ร.ยย."

ตอนที่ ๕ : กองพลทหารราบเบา พล.ร.7, 9 และ 15

พล.ร. เบา

เป็นรูปแบบการจัดกองพลทหารราบ โดยมีความมุ่งหมายที่จะใช้ตอบสนอง ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในด้านการรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันประเทศ และภารกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม ปัจจุบันหน่วยที่มีการจัดรูปแบบนี้ ได้แก่ พล.ร.๗,๙และ ๑๕ คำย่อที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้ จะใช้คำว่า "พล.ร.เบา"

รายละเอียดการจัด ภารกิจ ขีดความสามารถ ข้อจำกัดสะแกนเลย

กรมทหารราบ (มาตรฐาน)

อจย. 7-11 (25 ก.พ.52)

ภารกิจ

ทำลาย กำลังรบของข้าศึก เข้ายึด และควบคุมพื้นที่ รวมทั้งประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่

การแบ่งมอบ

เป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหารราบ

ขีดความสามารถ

ก. ควบคุม บังคับบัญชา และดำเนินการทางธุรการ ต่อกองพันทหารราบ และ หน่วยทหารในอัตรา ในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก และการรบด้วยวิธีรับ รวมทั้งการปราบปรามการก่อความไม่สงบ

ข. ปฏิบัติการรบอย่างต่อเนื่อง ต่อกำลังรบของข้าศึกที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเดียวกัน หรือต่ำกว่า ภายในกรอบของกองพล หรือปฏิบัติการเป็นอิสระเมื่อได้รับการเพิ่มเติมกำลังอย่างเหมาะสม

ค. ปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศ หรือสภาพอากาศยากลำบาก

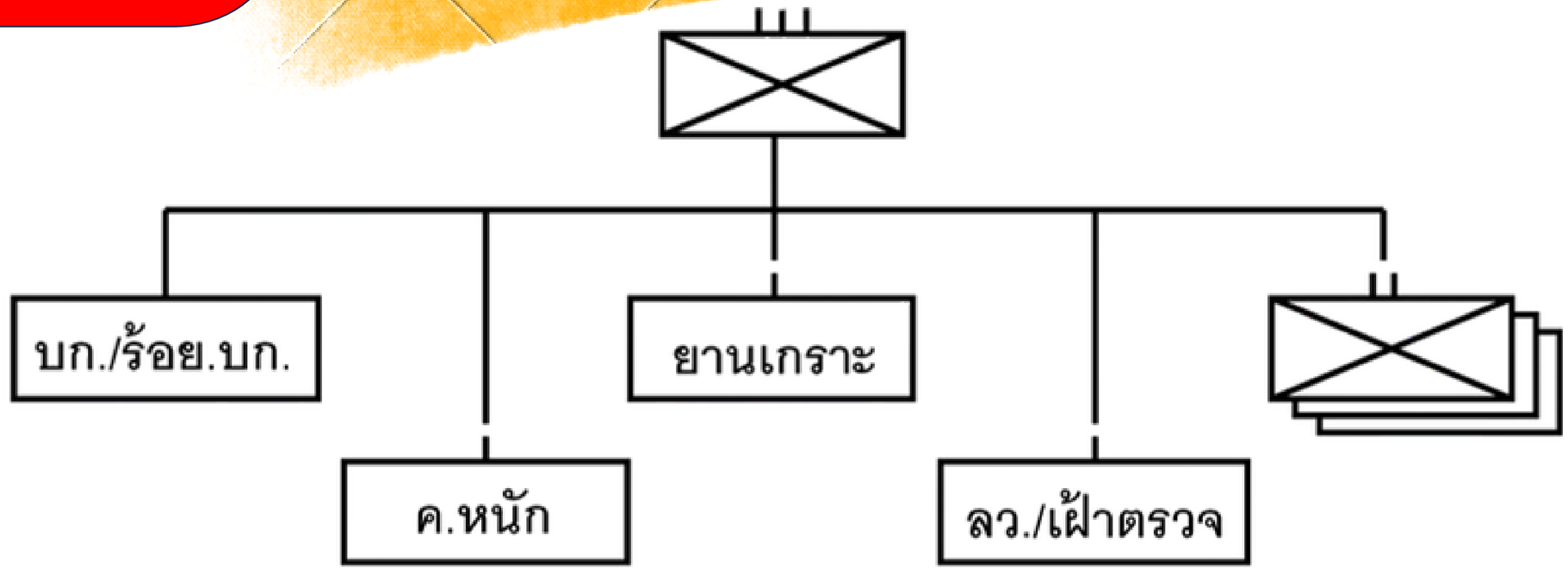
ง. เข้าควบคุมประชากรในดินแดนที่ยึดได้

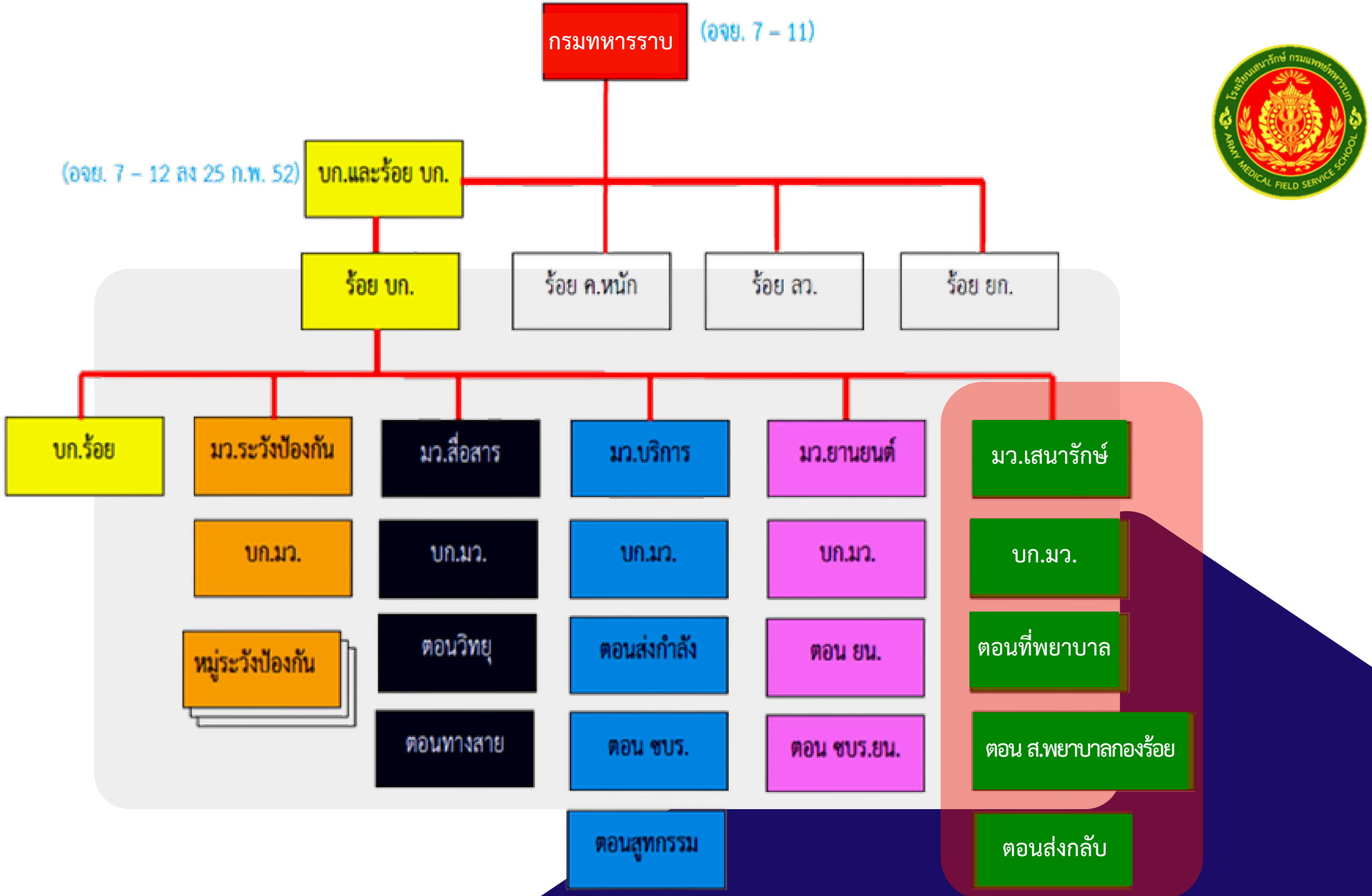
จ. ฟื้นฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ยึดได้

กรมทหารราบ (มาตรฐาน)
อจย. 7-11 (25 ก.พ.52)

การจัด

ประกอบด้วย
- 1 กองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการ (บก.และ ร้อย.บก.)
- 1 กองร้อยเครื่องยิงหนัก (ร้อย.ค.หนัก)
- 1 กองร้อยยานเกราะ
- 1 กองร้อย ลว./เฝ้าตรวจ
- 3 กองพันทหารราบ (พัน.ร.)




กรมทหารราบ
(อจย. 7 – 11)
(อจย. 7 – 12 ลง 25 ก.พ. 52)
บก.และร้อย บก.
ร้อย บก.
ร้อย ค.หนัก
ร้อย ลว.
ร้อย ยก.
บก.ร้อย
มว.ระวังป้องกัน
มว.สื่อสาร
มว.บริการ
มว.ยานยนต์
มว.เสนารักษ์
บก.มว.
บก.มว.
บก.มว.
บก.มว.
บก.มว.
หมู่ระวังป้องกัน
ตอนวิทยุ
ตอนส่งกำลัง
ตอน ยน.
ตอนที่พยาบาล
ตอนทางสาย
ตอน ชบร.
ตอน ชบร.ยน.
ตอน ส.พยาบาลกองร้อย
ตอนสูทกรรม
ตอนส่งกลับ

มว.สร.ร้อย.บก.กรม ร.
อจย.7-12 (25 ก.พ.52)

การจัด

เป็นหน่วยในอัตราของ ร้อย บก.กรม ร. ประกอบไปด้วย
- บก.มว.
- ตอนที่พยาบาล
- ตอน ส.พยาบาลกองร้อย
- ตอนส่งกลับ

ภารกิจ

ให้การบริการทางการแพทย์แก่หน่วยต่างๆของ กรม.ร. (ยกเว้น พัน. ร.) และหน่วยต่าง ๆ ที่มาขึ้นสมทบ กรม.ร.

มว.สร.ร้อย.บก.กรม ร.
อจย.7-12 (25 ก.พ.52)

การจัด/กำลังพล

รวม 33 นาย

มว.สร.ร้อย.บก.กรม ร.

อจย. 7-12 (25 ก.พ. 52)

บก.มว.

ผบ.มว.(นพ.) ร.อ. 1
รอง ผบ.มว. ร.ท. 1
พลขับ จ. 1

รวม 3 นาย

ตอนที่พยาบาล

ผบ.ตอน จ.(พ) 1
ส.พยาบาล จ. 1
ส.อ. 2
พลเสนารักษ์ ส.ต. 1
พลฯ 3

รวม 8 นาย

ตอน ส.พยาบาล กองร้อย

สน.ร้อย.ค.หนัก จ. 1
ส.อ. 2
สน.ร้อย.ยก. จ. 1
สน.ร้อย.ลว./ฝต. จ. 1
ส.อ. 2

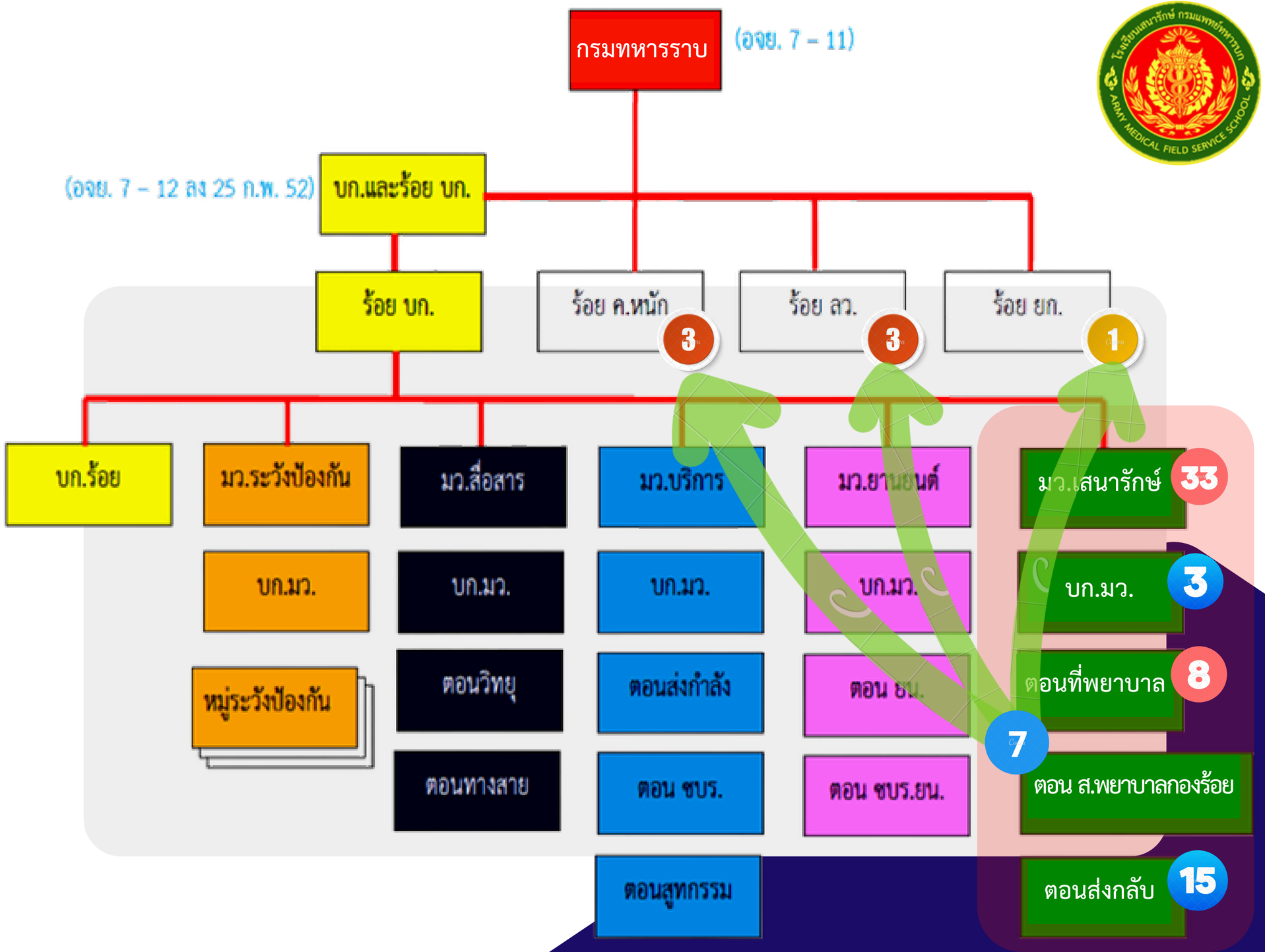
รวม 7 นาย

ตอนส่งกลับ

ผบ.ตอน จ. 1
ส.พยาบาล ส.อ. 3
พลขับ ส.อ. 3
พลเปล ส.ต. 2
พลฯ 6

รวม 15 นาย

การสนับสนุน ส.พยาบาล



กองพันทหารราบ

อจย. 7-15 (25 ก.พ.52)

ภารกิจ

1. เข้าประชิดข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิงและการดำเนินกลยุทธ์เพื่อทำลาย และจับข้าศึก
2. ผลักดันการเข้าตี ของข้าศึกด้วยการยิง การรบประชิด และการตีโต้ตอบ

การแบ่งมอบ

เป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารราบ

ขีดความสามารถ

1. จัดให้มีฐานยิง และส่วนดำเนินกลยุทธ์
2. ยึดและรักษาภูมิประเทศได้
3. ดำเนินกลยุทธ์ได้ทุกสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
4. ให้การยิงสนับสนุนแก่หน่วยในอัตรา และหน่วยขึ้นสมทบ
5. ทำการป้องกันต่อสู้รถถัง และอากาศยานได้อย่างจำกัด
6. ปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศได้ เมื่อได้รับการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศอย่างเพียงพอ
7. เข้าปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกได้
8. เคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะในอัตราได้ 100 %

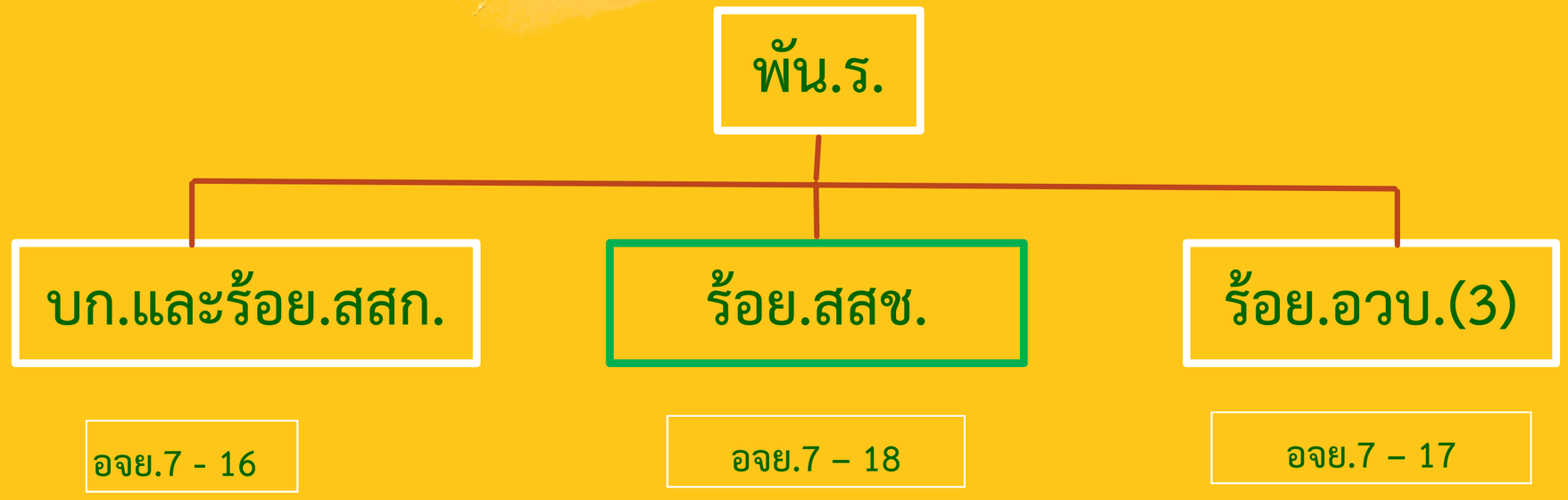
กองพันทหารราบ

อจย. 7-15 (25 ก.พ.52)

การจัด

ประกอบด้วย
- 1 บก. และ ร้อย.สสก.
- 1 ร้อย.สสช.
- 3 ร้อย.อวบ.

Canva



กองพันทหารราบ

อจย. 7-15 (25 ก.พ.52)

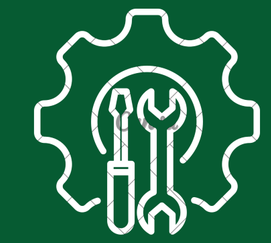
- พัน.ร.
  - บก.และ ร้อย สสก.
  - ร้อย สสช.
    - บก.ร้อย
    - มว.บริการ
      - บก.มว.
      - ตอนส่งกำลัง
      - ตอนสูทกรรม
      - ตอน ซบร.
    - มว.ยานยนต์
      - บก.มว.
      - ตอนยานยนต์
      - ตอนซ่อมบำรุง
      - ตอนธุรการ
    - มว.สร.
      - บก.มว.
      - ตอนที่พยาบาล
      - ตอน ส.พยาบาลกองร้อย
      - ตอนส่งกลับ
  - ร้อย. อวบ.

การบริการทางการแพทย์

ระดับหน่วย

มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

- เป็นหน่วยขึ้นตรง ร้อย สสช.พัน.ร.
- มี ผบ.ร้อย. สสช.พัน.ร. เป็นผู้บังคับบัญชา
- ได้รับการสนับสนุนจาก ร้อย สสช.พัน.ร. คือ

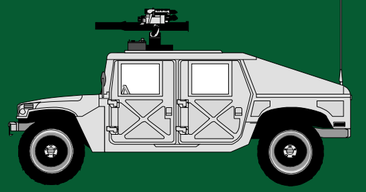


- การส่งกำลังทั่วไป
- การเลี้ยงดู
- การซ่อมบำรุง

มว.บริการ

* การขนส่ง
* การซ่อมบำรุงยานยนต์

มว.ยานยนต์



การจัด ภารกิจ และกำลังพล มว.สร.ฯ

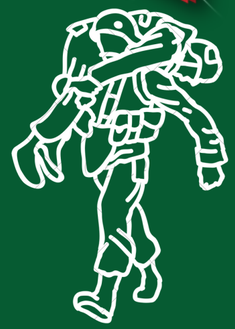
มว.สร.ร้อย สสช.พัน.ร. อจย. 7-18 (25 ก.พ. 52)

บก.มว.	ตอนที่พยาบาล	ตอน ส.พยาบาล กองร้อย	ตอนส่งกลับ
3 นาย	**8 นาย**	**15 นาย**	**19 นาย**
ผบ.มว.สร.(นพ.) ร.อ. 1	ผบ.ตอน จ.(พ) 1	ผบ.ตอน จ. 1	ผบ.ตอน จ. 1
รอง ผบ.มว.สร. ร.ท. 1	นายสิบพยาบาล จ. 2	ส.พยาบาล จ. 2	ส.พยาบาล ส.อ. 3
พลขัย จ. 1	ส.อ. 1	สอ. 12	พลขับรถ ส.อ. 3
	ส.ต.กองฯ 1		หน.พวกเปล ส.ต. 3
	พลเสนารักษ์ 3		พลเปล พลฯ 9

ภารกิจ

ให้การบริการทางการแพทย์แก่ พัน.ร. (ยกเว้นกรม ร.)
และหน่วยต่าง ๆ ที่มาขึ้นสมทบ พัน.ร.

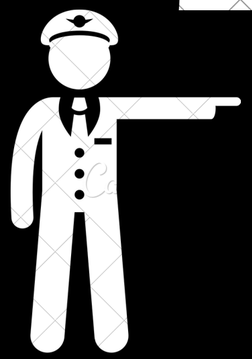
รวมทั้งสิ้น 45 นาย



การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์

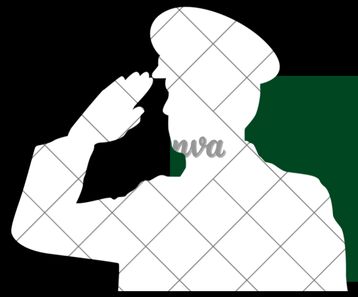


มีหน้าที่

1. เป็น **นายทหารฝ่ายกิจการพิเศษ** (สายแพทย์) ของ ผบ.พัน.ร.
2. ทำหน้าที่ **ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์** ร้อย.สสช.พัน.ร.
3. เป็น **นายแพทย์** รักษากำลังพลทั้งนอกสถานการณ์รบ และในสถานการณ์รบ

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

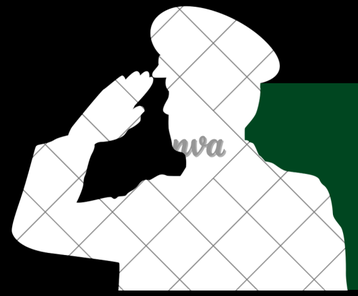


ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์

ในฐานะ ฝ่ายกิจการพิเศษ สาย พ. ของ ผบ.พัน.ร. มีหน้าที่ดังนี้

1. วางแผนและสั่งการการปฏิบัติทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุน พัน.ร.
2. ประกันในการรับผู้ป่วยเจ็บได้ทันที และมีประสิทธิภาพ
3. ประสานงานกับ ฝอ.1 เกี่ยวกับยอดผู้ป่วยเจ็บที่รับไว้รักษา และที่จำหน่าย (รวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วย)
4. ประสานงานกับ ฝอ.2 เกี่ยวกับการตรวจ สป. หรือ เอกสารทางการแพทย์ที่ยึดได้จากเชลยศึก และร่วมสัมภาษณ์เชลยศึกที่เจ็บป่วย

มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.



ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์

ในฐานะ ฝ่ายกิจการพิเศษ สาย พ. ของ ผบ.พัน.ร. มีหน้าที่ดังนี้

5. ช่วยเหลือ ฝอ.3 ในการวางแผน กำกับดูแลการฝึก ประสานการปฏิบัติและแผนทางยุทธวิธีตลอดเวลา

6. ประสานกับ ฝอ.4 เกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง (รวมทั้งงานสายแพทย์) กำหนดพื้นที่จัดตั้งที่พยาบาลกองพัน

7. วางระดับ สป.สาย พ.ต่าง ๆ เพื่อให้พอเพียง

8. เสนอแนะ ผบ.พัน.ร.และ ฝอ.เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์

9. แจ้งสถานการณ์ทางการแพทย์ให้ ผบ.พัน.ร., ฝอ. และ พญ. ของหน่วยเหนือทราบ

มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

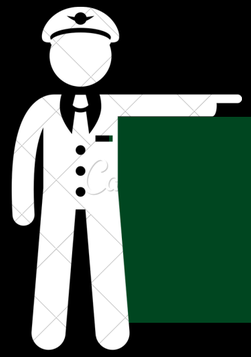
ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์

ในฐานะ ฝ่ายกิจการพิเศษ สาย พ. ของ ผบ.พัน.ร. มีหน้าที่ดังนี้

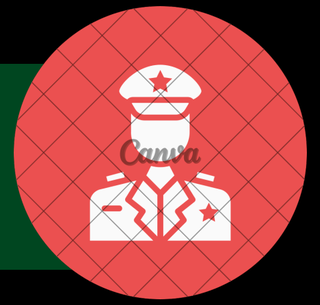
10. บันทึกและรายงานทางการแพทย์ตามห้วงระยะเวลา
11. ประกันการปฏิบัติของเจ้าที่แพทย์ทุกนายว่าปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
12. ประมาณสถานการณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.



ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์



ในฐานะ ผบ.มว.สร.ร้อย สสช.พัน.ร.

บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของ มว.สร. ในเรื่อง

- ธุรการ การสวัสดิการ
- วินัย การจัด การฝึกและการใช้ มว.สร.
- การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ ในพื้นที่ พัน.ร.

การบริการทางการแพทย์

ระดับหน่วย

มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์

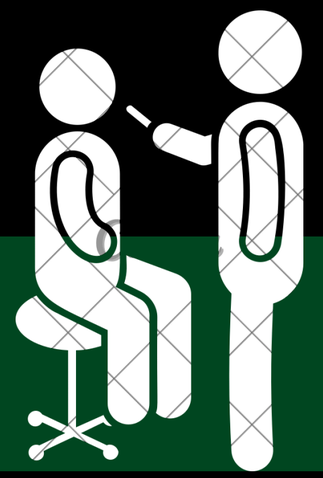
ในฐานะ นายแพทย์

ทำการตรวจรักษา กำลังพลของ พัน.ร. และหน่วยที่มาสมทบ
ทั้งนอก และในสถานการณ์รบ ทำการคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ
ของที่พยาบาลกองพัน ที่ส่งกลับมาจากแนวหน้า

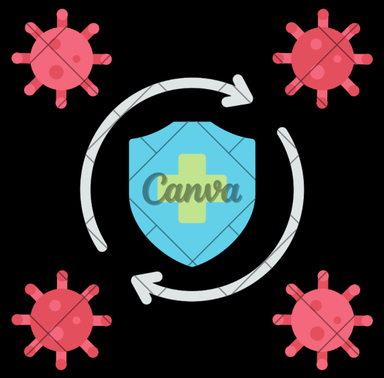
เป็นนายแพทย์คนแรก
ที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บใน แนวหน้า

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.



หน้าที่



1. นอกสถานการณ์รบ
   1.1 เปิดที่ตรวจโรค ตามความจำเป็น
   1.2 ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการเวชกรรมป้องกัน
   1.3 ทำการฝึกหน่วยเพื่อสนับสนุนการรบ
   1.4 ฝึกสอนกำลังพลของ พัน.ร. เรื่อง การปฐมพยาบาล สุขศาสตร์ส่วนบุคคล และการเวชกรรมป้องกัน

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

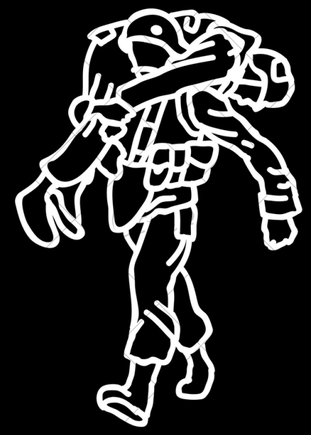
หน้าที่

2. ในสถานการณ์รบ

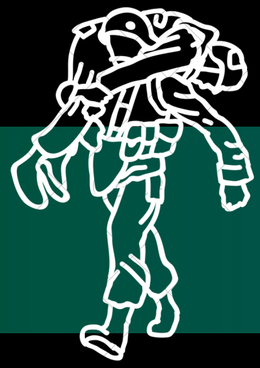
มีงานเพิ่มจากงานนอกสถานการณ์รบ คือ

2.1 จัดนายสิบพยาบาลกองร้อย ไปสมทบหน่วยรบตามอัตรามูลฐาน 4 นาย ต่อ 1 ร้อย.อวบ.(1 นาย ต่อ 1 มว.ปล. และอีก 1 นาย ที่ ทก.ร้อย.อวบ.) หรือตามความจำเป็น

2.2 จัดตั้ง ⊔ ทำการคัดแยกผู้ป่วยเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเพิ่มเติมต่อจากนายสิบพยาบาลกองร้อย



การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.



หน้าที่

2. ในสถานการณ์รบ

2.3 ทำการส่งกลับ ผป.เจ็บจากสนามรบ มายังที่พยาบาลกองพัน และประสานการส่งกลับไปยังที่พยาบาลกองพลหน้า

2.4 ให้บริการทางการแพทย์ทางท้ายรถ (Tailgate Medical Service) เมื่อหน่วยดำเนินกลยุทธเคลื่อนที่เร็ว

2.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการเวชกรรมป้องกัน

ใช้อาคารต่าง ๆ พื้นดินตามเส้นทางการเคลื่อนย้าย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

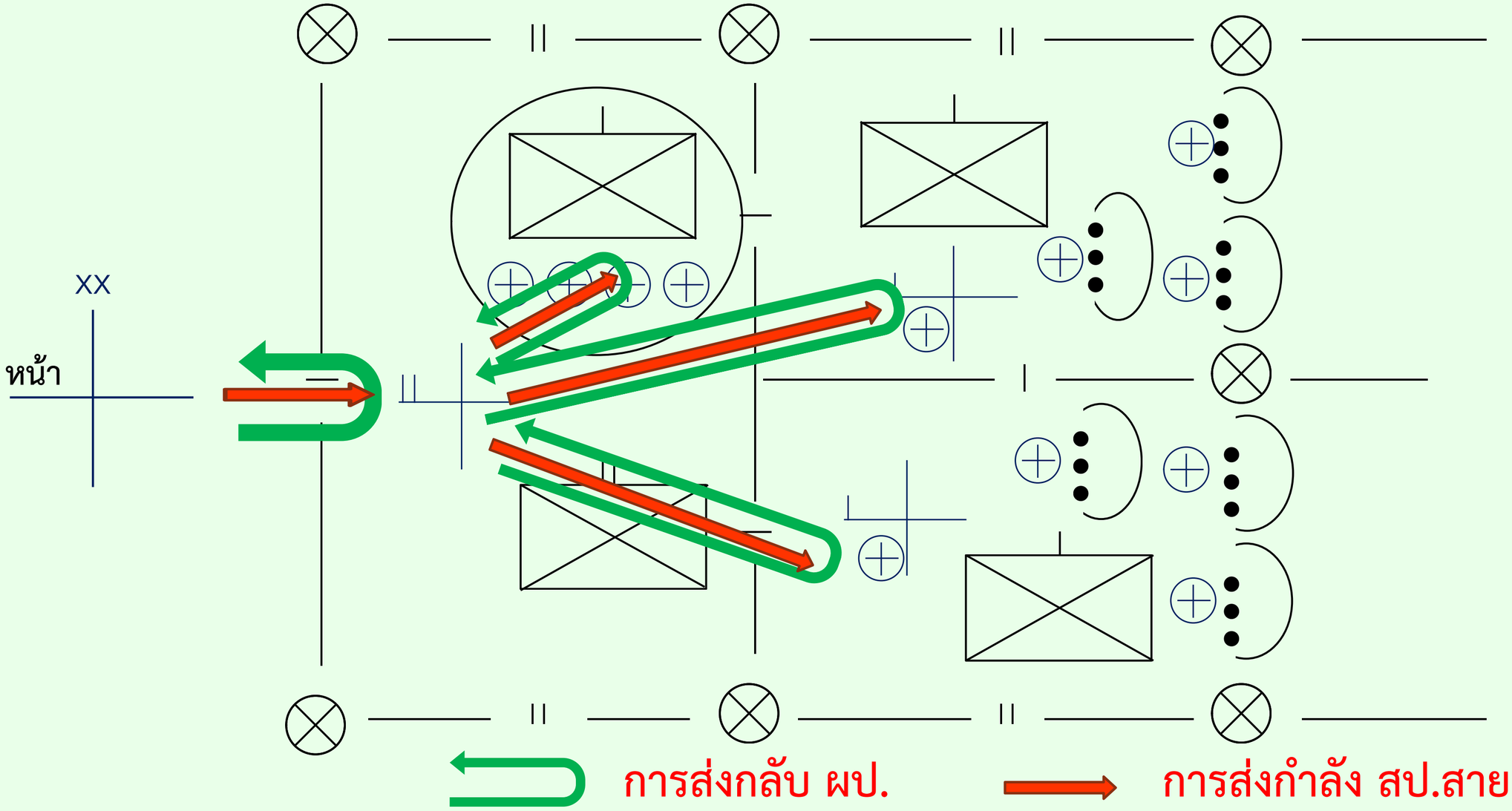
การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย

Unit Level Health Service Support

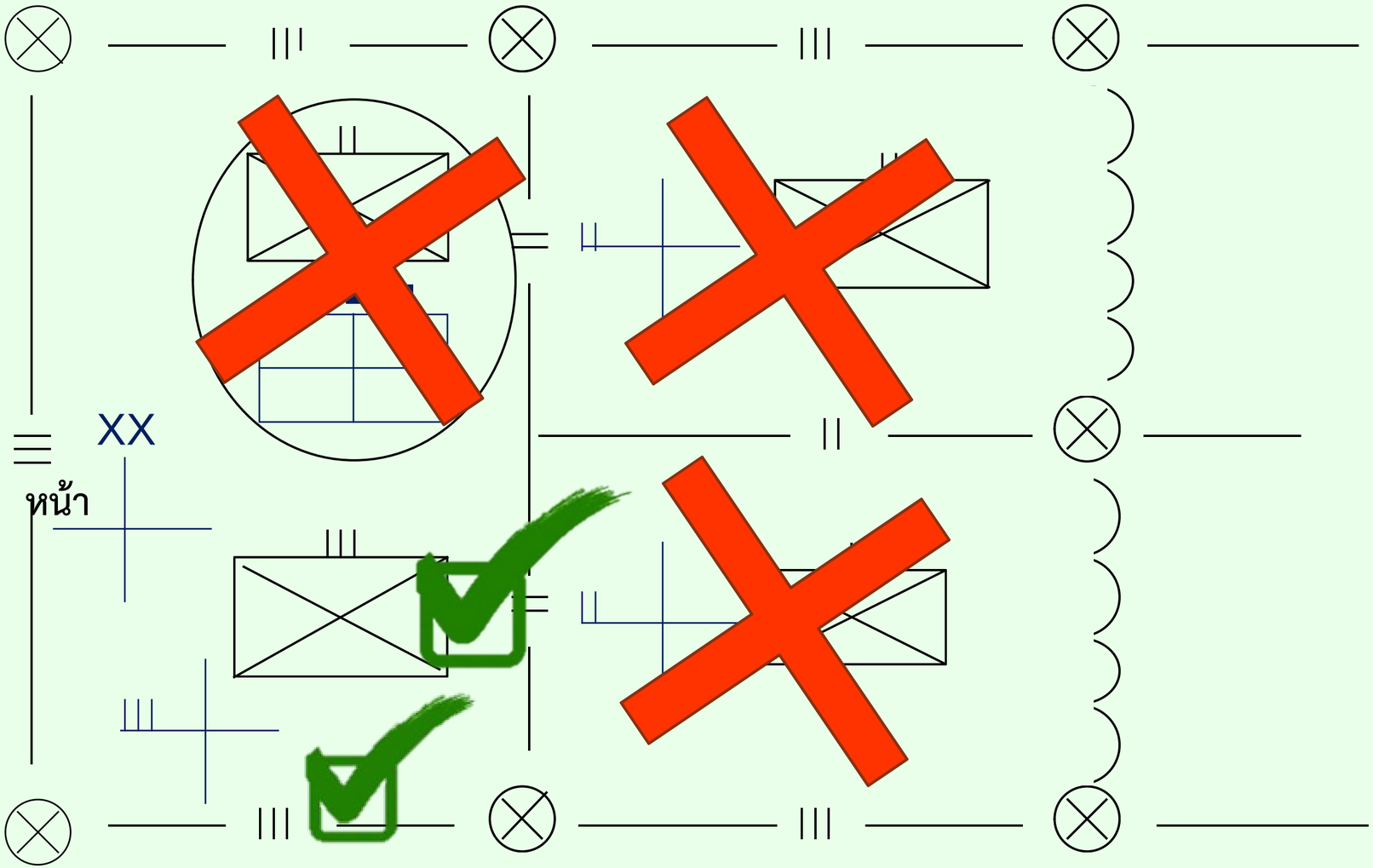
หน่วยแพทย์ที่อยู่ข้างหน้าสุดได้แก่ มว.สร.
(Medical Platoon)
จัดตั้ง ที่พยาบาลกองพัน (Battalion Aid Station = BAS.)
ให้การรักษาพยาบาลและทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากพื้นที่การรบ

ความคล่องตัวสูง, การรักษาไม่สมบูรณ์

การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย
มว.สร.ร้อย.สสช.พัน.ร. ในสถานการณ์รบ



การบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ของ กรม ร.



การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

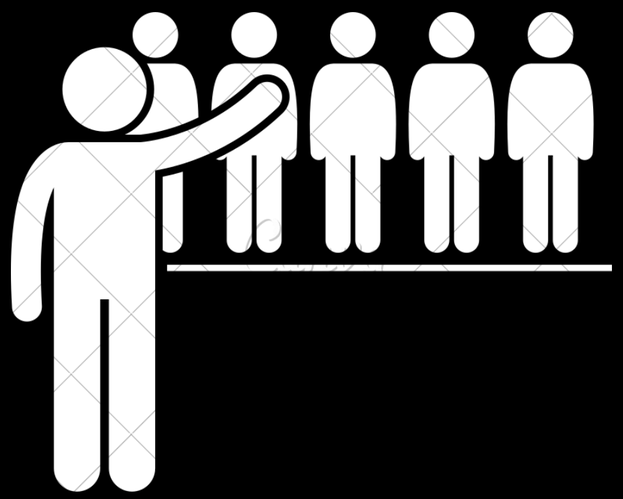
บก.มว.

จัดตั้ง

- ทก.มว.สร.
- ที่พยาบาลกองพันไม่เกิน 1 แห่ง

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

บก.มว.



- กำลังพล 3 นาย
- ผบ.มว.สร. เป็นนายแพทย์, รอง ผบ.มว., พลขับ
- หน้าที่ของ บก.มว. คือ
  - ควบคุมบังคับบัญชา
  - อำนวยการและสั่งการปฏิบัติ

การรักษาพยาบาลของหน่วยเสนารักษ์ในแนวหน้า
จะมีลักษณะ ความคล่องตัวสูง, การรักษาไม่สมบูรณ์

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

บก.มว.

รอง ผบ.มว.สร.
มีหน้าที่

- เป็น นายทหารพยาบาล อัตรา ร.ท.
- เป็นผู้ช่วยของ ผบ.มว.สร.
- ลาดตระเวนหาที่ตั้ง ที่พยาบาลกองพัน
- กำกับดูแลการจัดตั้ง ที่พยาบาลกองพัน
- ประสานการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ
- กำกับดูแลการปฏิบัติทางธุรการ
- ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับมอบ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนที่พยาบาล

ผบ.ตอนที่พยาบาล มีหน้าที่

- จัดตั้ง ⊥ ในพื้นที่ที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
- จัดระเบียบภายใน ⊥
- ดูแลเก็บรักษา, รายงานเบิก สป.สาย พ.
- ควบคุมการแลกเปลี่ยน สป.ที่ติดตัวผู้ป่วยเจ็บ
- ทำบันทึก เอกสารทางการแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน
- จัดเตรียม ผป.เจ็บที่จะส่งกลับไปรักษาพยาบาลต่อ
- ช่วยรักษาพยาบาล ผป.เจ็บ ตามที่นายแพทย์ สั่ง

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนที่พยาบาล

นายสิบพยาบาล มีหน้าที่

เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง **การปัจจุบันพยาบาล**

พลเสนารักษ์ มีหน้าที่

มีหน้าที่ช่วยเหลือ ผบ.ตอนที่พยาบาล/นายสิบพยาบาล ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอน ส.พยาบาลกองร้อย

ผบ.ตอน ส.พยาบาลกองร้อย

- จัดนายสิบพยาบาลกองร้อย สมทบ ร้อย อวบ. ใน 1 กองร้อย จัด ส.พยาบาลฯ 4 นาย
  - หน. ส.พยาบาลกองร้อย 1 นาย สมทบ ทก.ร้อย
  - ส.พยาบาล 3 นาย สมทบ มว.ปล.
- หน่วยกำลังรบร้องขอจัดได้ตามความเหมาะสม (มว.ค.60, ตอน ค.81)

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

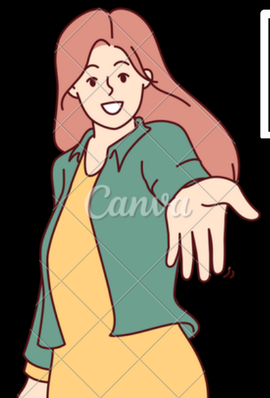
ตอน ส.พยาบาลกองร้อย

จัด ส.พยาบาลกองร้อยให้ ร้อย.อวบ. 4 นายต่อ 1 กองร้อย หรือตามความเหมาะสม

ส.พยาบาลกองร้อย 1 นาย

ส.พยาบาลกองร้อย 3 นาย (มว.ปล. = 1 นาย)

- ร้อย.อวบ.
  - บก.ร้อย
  - มว.อาวุธ
    - ตอน ค.81
    - ตอน ตถ.
  - มว.ปล.
    - บก.มว.
    - หมู่ ปล.



การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอน ส.พยาบาลกองร้อย

จัด ส.พยาบาลกองร้อยให้ ร้อย.อวบ. 4 นายต่อ 1 กองร้อย หรือตามความเหมาะสม

เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการปัจจุบันพยาบาลเป็นอย่างดี **นายสิบพยาบาลกองร้อยที่สมทบกับ ร้อย อวบ. จะร่วมทำการฝึกและร่วมรบ** กับ ร้อย.อวบ.

เพื่อให้การปัจจุบันพยาบาลแก่กำลังพลที่ป่วยหรือบาดเจ็บ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนส่งกลับ

"การส่งกลับ" คือ

การนำผู้ป่วยเจ็บออกจากสนามรบ
หรือหน่วยแพทย์ข้างหน้า
ส่งไปยังหน่วยแพทย์ข้างหลัง
โดย **หน่วยแพทย์ข้างหลัง เป็นผู้รับผิดชอบ**

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนส่งกลับ

ผบ.ตอนส่งกลับ มีหน้าที่

- ควบคุมเครื่องมือการส่งกลับและ สป.ต่างๆ เช่น รถยนต์พยาบาล เปล เฝือก ผ้าห่ม สายรัดห้ามเลือด
- ทำการลาดตระเวนหาเส้นทางการส่งกลับ เส้นทางการลำเลียงด้วยเปล และรถยนต์พยาบาล โดยกำหนดเส้นทางหลัก เส้นทางรอง
  - การส่งกำลัง สป.สาย พ.
  - ส่งข่าวสาร
  - การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของตอนส่งกลับ
  - กำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของตอนส่งกลับ

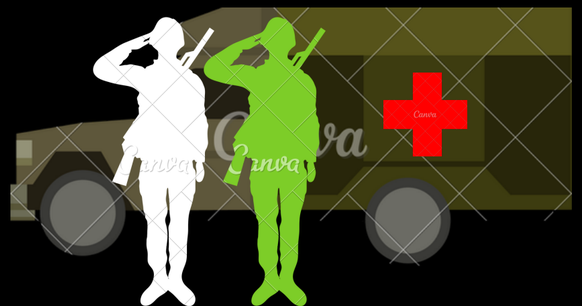
การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนส่งกลับ

เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการให้การปัจจุบันพยาบาล

ได้รับการจัดให้ประจำรถยนต์พยาบาล
1 คน ต่อ 1 คัน
พร้อมด้วยกระเป๋าพยาบาล เป็นผู้ให้การปัจจุบันพยาบาล หรือให้การปัจจุบันพยาบาลเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยเจ็บระหว่างทาง



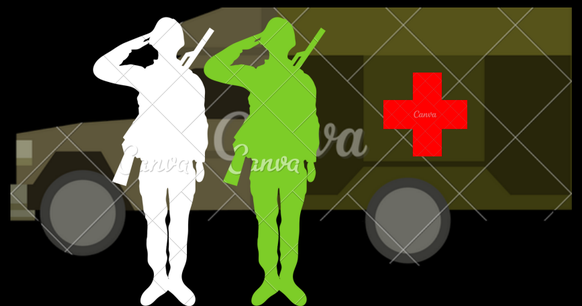
การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนส่งกลับ

พลขับรถ

เป็นเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์พยาบาล เพื่อทำการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากพื้นที่การรบมายังที่พยาบาลกองพัน

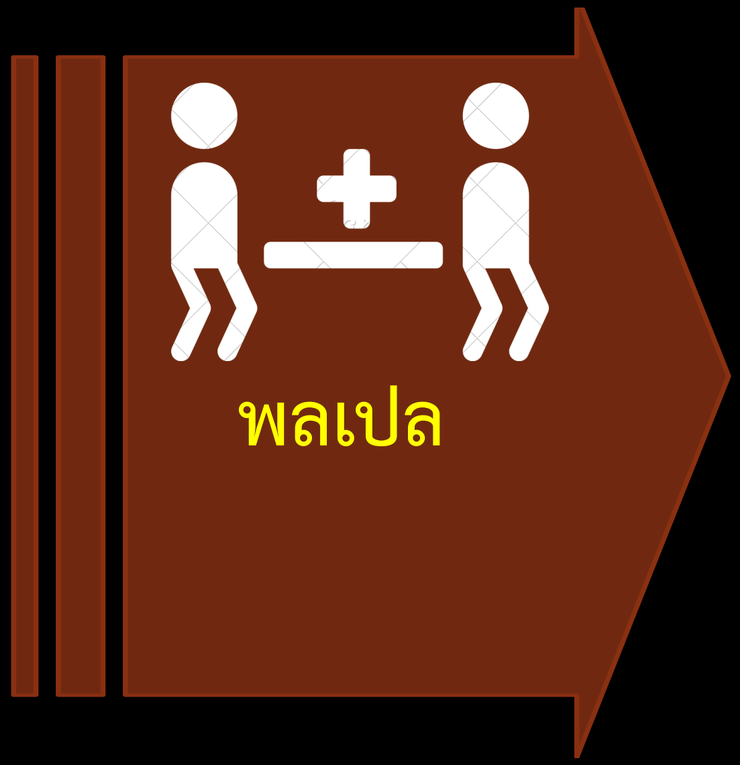
- การส่งกำลัง สป.สาย พ.
- การนำสาร
- ปฐมพยาบาลได้



การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตอนส่งกลับ



มีหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บจาก มว.ปล. มายังที่พยาบาลกองร้อย หรือจากตำบลรวบรวมผู้ป่วยเจ็บมายังเส้นหลักการรุกเป็นการปฏิบัติตามยุทธวิธี รวมทั้งการส่งกำลัง สป. และการนำสาร

(ผู้ที่รวบรวมผู้ป่วยเจ็บ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ มายังที่พยาบาลกองร้อย)

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

จัดตั้งโดย
ผบ. ตอนที่พยาบาล

- ผบ.มว.สร.
  เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา และให้การดูแลรักษา ผป.
- ผบ.ตอนที่พยาบาล และนายสิบพยาบาล เป็นผู้ช่วยเหลือ

ผู้ที่กำหนดพื้นที่ให้ ให้ มว.สร.
จัดตั้งที่พยาบาลกองพันคือ
ฝอ. 4 พัน ร.

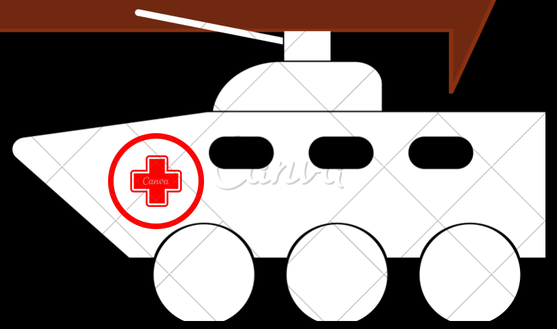
- ผบ.มว.สร. เลือกพื้นที่กว้าง ๆ
- รอง ผบ.มว.สร. เลือกพื้นที่เฉพาะ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

๔

แนวทางการจัดตั้ง



สามารถรับผู้ป่วยเจ็บได้ทันทีตามสถานการณ์
ควรอยู่ในพื้นที่ข้างหน้าของกองพัน ให้มากที่สุด
เท่าที่สถานการณ์จะอำนวยให้
โดยทั่วไปจะจัดตั้งใกล้กับ ทก.พัน.ร.

นโยบายในการส่งกลับ
จะเปลี่ยนแปลงไปโดยยึด
สถานการณ์ทางยุทธวิธี

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

ข้อพิจารณา
ในการเลือกที่ตั้ง

1. การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองพัน
2. พื้นที่ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเจ็บหนาแน่น
3. การระวังป้องกันที่ได้รับจากหน่วยอื่น
4. เส้นทางที่มาบรรจบกัน
5. การกำบังและซ่อนพราง
6. ความปลอดภัย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

ข้อพิจารณาในการเลือกที่ตั้ง

7. เส้นทางการส่งกลับ
8. ระยะทางการส่งกลับ
9. หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่มีลักษณะทางเป้าหมาย
10. มีพื้นที่เหมาะสำหรับ ฮ. ลง ได้
11. การติดต่อสื่อสาร

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

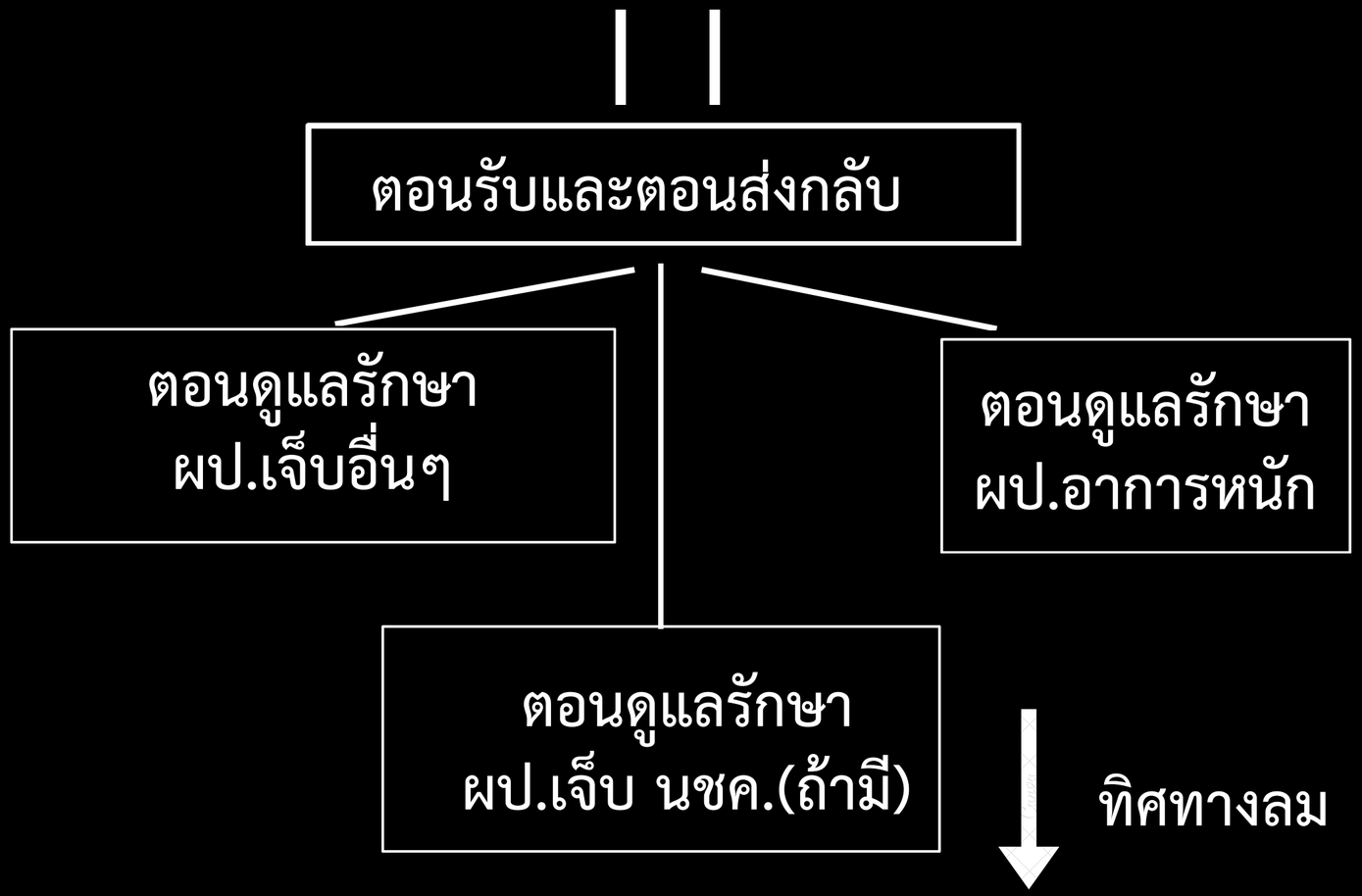
๔

การจัด
ระเบียบภายใน

- ตอนรับและตอนส่งต่อไป
- ตอนดูแลรักษาผู้ป่วยเจ็บอาการหนัก
- ตอนดูแลรักษาผู้ป่วยเจ็บอื่นๆ
- ตอนดูแลรักษาผู้ป่วยเจ็บ ชครน.(ถ้ามี)

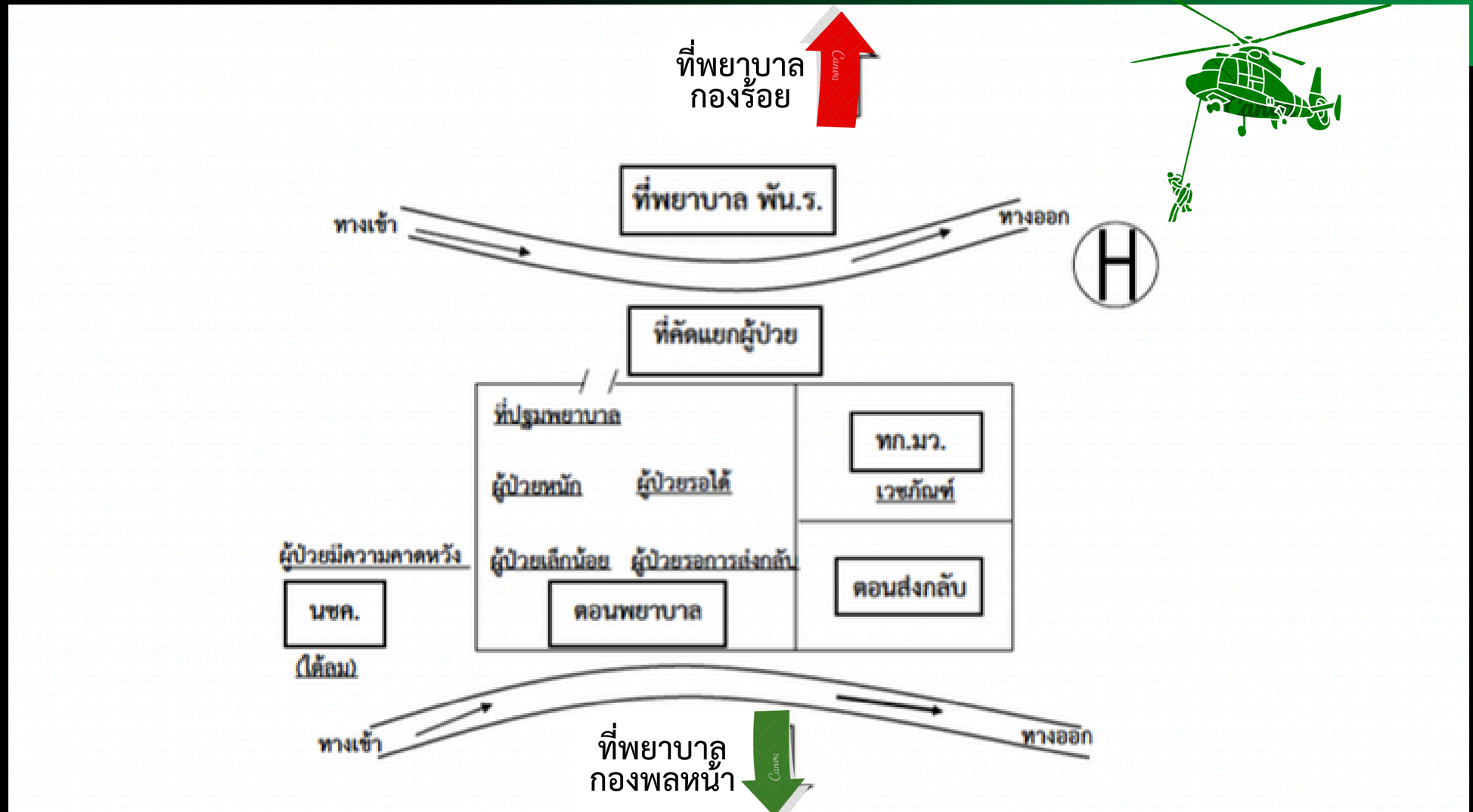
การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตัวอย่างการจัดระเบียบภายในที่พยาบาลกองพัน



การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ตัวอย่างการจัดระเบียบภายในที่พยาบาลกองพัน



การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

การปฏิบัติตามยุทธวิธี

ในสถานการณ์ยุทธเคลื่อนที่เร็ว

- ไม่สามารถจัดตั้งที่พยาบาลได้
- รักษาพยาบาลในรถยนต์พยาบาล หรือทางท้ายรถบริการทางการแพทย์ทางท้ายรถ (TALGATE MEDICAL SUPPORT)
- อาคารต่าง ๆ
  - พื้นดินตามเส้นทางการเคลื่อนย้าย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

การปฏิบัติตามยุทธวิธี

การเคลื่อนย้ายที่พยาบาลกองพัน

เพื่อดำรงการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับหน่วยที่รับการสนับสนุน การเคลื่อนย้ายมี 2 ลักษณะ

1. เคลื่อนย้ายโดยตรง
2. เคลื่อนย้ายตามลำดับขั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน
   - ส่วนล่วงหน้า
   - ส่วนฐาน

จำหน่ายผู้ป่วยหมดแล้ว คย.ติดตามไปรวมกับส่วนล่วงหน้า ณ ที่ตั้งใหม่

ติดตามหน่วยรบไปจัดตั้งที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งใหม่

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

1. รับและบันทึก ผป.เจ็บ
2. เมื่อสถานการณ์บ่งชี้เฝ้าตรวจ ผป.เจ็บว่าถูก คชรน. หรือไม่ก่อนให้การรักษา
3. ตรวจ คัดแยก ผป.เจ็บ ตามความรุนแรงของบาดแผลหรือบาดเจ็บ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

4. ให้การรักษาเร่งด่วนตามความจำเป็น
   - ให้การรักษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น
   - เตรียมผู้ป่วยเจ็บเพื่อการส่งกลับ
   - ส่งคืนผู้ป่วยเจ็บที่หายดีแล้ว
5. แจ้ง ฝอ. 1 พัน.ร. ให้ทราบถึงจำนวนผู้ป่วยเจ็บที่มาที่พยาบาลกองพัน
   - รวมทั้งบันทึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บตามที่กำหนดใน รปจ.

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

6. ตรวจสอบความถูกต้องในบัตรบันทึกการเจ็บป่วยในสนาม พ.ส.1 (ทบ.466 - 901) ที่ติดตัวมากับผู้ป่วยเจ็บ และเขียนเพิ่มเติมหรือเขียนใหม่ให้แก่ผู้ป่วยเจ็บที่ยังไม่มี เมื่อจะทำการส่งกลับ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

๑๐ การปฏิบัติทางเทคนิค

นโยบายการเก็บผู้ป่วยเจ็บไว้รักษาพยาบาลพิจารณาเป็นชั่วโมงมากกว่าเป็นวัน (ไม่เกิน 24 ชม.)

ข้อ 10 การกำหนดนโยบายการส่งกลับ

10.1 หน่วยเหนือมีหน้าที่กำหนดนโยบายการส่งกลับให้แก่หน่วยรอง

10.2 ให้ถือเกณฑ์นโยบายการส่งกลับโดยทั่วไปดังนี้.-

10.2.1 ที่พยาบาลกรม ไม่เกิน 10 วัน

10.2.2 ที่พยาบาลกองพล ไม่เกิน 20 วัน

10.2.3 หน่วยรักษาพยาบาลที่สนับสนุน ระดับกองทัพ ไม่เกิน 30 วัน

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

1. การใช้วิธีการผ่าตัดจะกระทำตามความจำเป็นเพื่อ
   - สงวนชีวิตและแขนขา
   - ให้ ผป.เจ็บมีอาการมั่นคงพอที่จะส่งกลับได้

2. การคัดแยก ผป.เจ็บ ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการส่ง ผป. กลับไปข้างหลังเกินความจำเป็น

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ
มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ (Sorting of Patients)

คือการจัดลำดับความเร่งด่วนในการรักษาพยาบาล และการส่งกลับ

เพื่อ การรักษาพยาบาล มี 4 ประเภท

1. ประเภททันที/รอไม่ได้ (Immediate) การรักษาเพื่อช่วยชีวิตไว้ทันที
2. ประเภทเล็กน้อย (Minimal) รักษาเพียงเล็กน้อย ก็สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่บางอย่างได้
3. ประเภทรอได้ (Delayed) อันตรายต่อชีวิตเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยมากหลังให้การรักษาในภาวะฉุกเฉินแล้ว
4. ประเภทพอมีหวัง/คาดว่าถึงแก่กรรม (Expectant) บาดเจ็บสาหัส ซึ่งคาดว่าจะเสียชีวิต แม้จะใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ทุ่มเทไปให้

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ (Sorting of Patients)

เพื่อการรักษาพยาบาล

ลำดับการรักษาพยาบาลใน ยามสงคราม

1. ประเภทเล็กน้อย (Minimal)
2. ประเภททันที/รอไม่ได้ (Immediate)
3. ประเภทรอได้ (Delayed)
4. ประเภทพอมีหวัง/คาดว่าถึงแก่กรรม (Expectant)

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ (Sorting of Patients)

เพื่อการส่งกลับ 4 ประเภท

การคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ เพื่อ **จัดลำดับความเร่งด่วนใน**

การส่งกลับ

1. **ด่วนที่สุด** (Urgent) ส่งกลับทันทีไม่เกิน 2 ชม.
   นับแต่เริ่มได้รับบาดเจ็บ
2. **ด่วน** (Priority) ส่งด่วน แต่รอได้ไม่เกิน 4 ชม.
   คาดว่าจะมีอาการรุนแรงมากในภายหลัง
3. **ธรรมดา** (Routine) รอได้นานเกิน 4 ชม.
   คาดว่าจะไม่มีอาการทรุดหนัก ทรงตัวได้มากกว่า 4 ชม.
4. **ด่วนยุทธการ** (Tactical Urgent) **ผบ.หน่วยทาง**
   จำเป็นต้องส่งกลับ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ
   เนื่องจากเป็นความต้องการทางยุทธวิธี

ยุทธวิธีรับผิดชอบ

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การส่งกลับ

การส่งกลับทางการแพทย์ หรือ การส่งกลับ ผป.เจ็บ คือ การเคลื่อนย้าย ผป.เจ็บจากจุดบาดเจ็บ (สนามรบ) หรือจากหน่วยแพทย์ที่อยู่ **ข้างหน้า** มายังหน่วยแพทย์ที่อยู่ **ข้างหลัง**

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

การปฏิบัติทางเทคนิค
ผบ. มว. สร.

ในฐานะนายแพทย์ ทำการรักษาผู้ป่วยเจ็บและกำกับดูแลในเรื่อง

1. การรับ ผป.เจ็บ
2. การทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ
3. การฉีดยา และการให้ของเหลวทางเส้นเลือด
4. การป้องกันและรักษาช็อก
5. การใช้ผ้าแต่งแผลทำแผล
6. การจัดตั้งเครื่องมือและเก็บเครื่องมือ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

ขีดความสามารถทางการแพทย์

ก. เป็นการรักษาที่ไม่เฉพาะและไม่สมบูรณ์

1. ให้การรักษาพยาบาลต่อจาก ส.พยาบาลกองร้อย
2. ให้ของเหลวทางเส้นโลหิต
3. การผ่าตัดแก้ไขทางเดินหายใจ
4. การเจาะช่องอก
5. บล็อกเส้นประสาท
6. การผูกเส้นเลือดห้ามเลือด

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

ก. เป็นการรักษาที่ไม่เฉพาะและไม่สมบูรณ์

7. การผ่าตัดเส้นเลือดให้ของเหลว
8. การให้ยารักษา
9. การพันผ้าการแต่งแผลและการเข้าเฝือก
10. การปฐมพยาบาลทางจิตประสาท
11. นอกสถานการณ์รบ เปิดที่ตรวจโรคให้บริการทางการแพทย์แบบพื้นที่

ข.จัดท่าผู้ป่วยเจ็บและเตรียมการส่งกลับ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

ก. ใช้วิธีรักษา**ช่วยชีวิตเร่งด่วนเท่านั้น**

ข. **หลีกเลี่ยง**การใช้วิธีรักษาที่สมบูรณ์ เช่น

1. การตัดแต่งแผล
2. การจัดกระดูกให้เข้าที่
3. การรักษาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ยาสลบ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

1. ส่งคืนไปปฏิบัติหน้าที่ ตามเดิม
2. ผป.เจ็บที่รักษาในที่พยาบาลกองพัน ไม่หาย และ ผป.เจ็บทางทันตกรรม จะถูกส่งกลับไปยังที่พยาบาลกองพลหน้า
   - กรณีฉุกเฉิน(สาหัส) ส่งกลับโดย ฮ.
   - ขอตามสายการบังคับบัญชา โดยนายแพทย์ พัน.ร. ร้องขอการส่งกลับทางอากาศ
   - กระทำโดย ฮ.พยาบาล ของ ร้อย.บินปีกหมุนพยาบาล ทบ.

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

๔

การบันทึกต่าง ๆ

1. ทำบัญชีรายชื่อ ผป. ที่ให้การรักษาพยาบาล เพื่อ
   - ผบ.มว.สร. จะใช้บัญชีนี้ทำรายงาน และทำข่าวสารเกี่ยวกับอัตราการป่วยเจ็บของกำลังพล ต่อ ผบ.พัน.ร.
   - สำหรับการวางแผนของ ผบ.มว.สร. เอง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของบัตร บันทึกการเจ็บป่วยในสนาม พ.ส.1 (ทบ.466-901)

นพ.พัน.ร.เซ็นชื่อกำกับ

ติดตัวไปจนถึงที่ส่งกลับแห่งสุดท้าย

ผู้ป่วยเจ็บประเภทที่ไม่ต้อง เขียนบัตร พ.ส.1 ผู้ป่วยเจ็บที่ส่งคืน

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

๔ เครื่องมือขนส่ง

ยานพาหนะในอัตรา

-รยบ.2 1/2 ตัน 1 คัน

- รยพ.ขนาด 1 ¼ ตัน 3 คัน รับผู้ป่วยนอน 4 คน นั่งได้ 8 คน

- รยพ.ขนาด ¼ ตัน รับผู้ป่วยนอนได้ 3 คน นั่งได้ 6 คน

- รถธุรการ ¼ ตัน 1 คัน

ยานพาหนะของ มว.สร. ได้รับการสนับสนุนการซ่อมบำรุงขั้นหน่วย จาก ตอนซ่อมบำรุง มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช.พัน.ร.

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

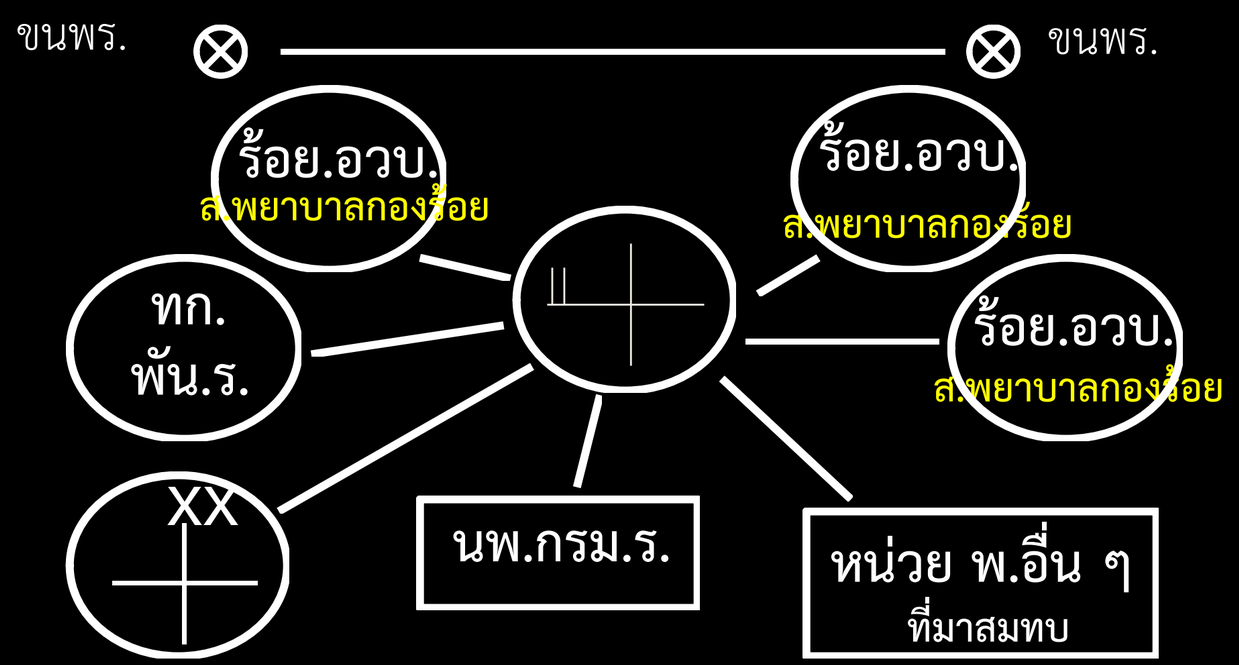
การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

(ของ ทก.มว.สร. & ที่พยาบาลกองพัน)

เครื่องมือสื่อสาร

การติดต่อสื่อสาร



เครื่องมือหลัก - วิทยุ - โทรศัพท์

เมื่อมีความจำเป็น -พลขับ -พลเปล -ผป.เจ็บ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน

ก. สป.สาย พ.

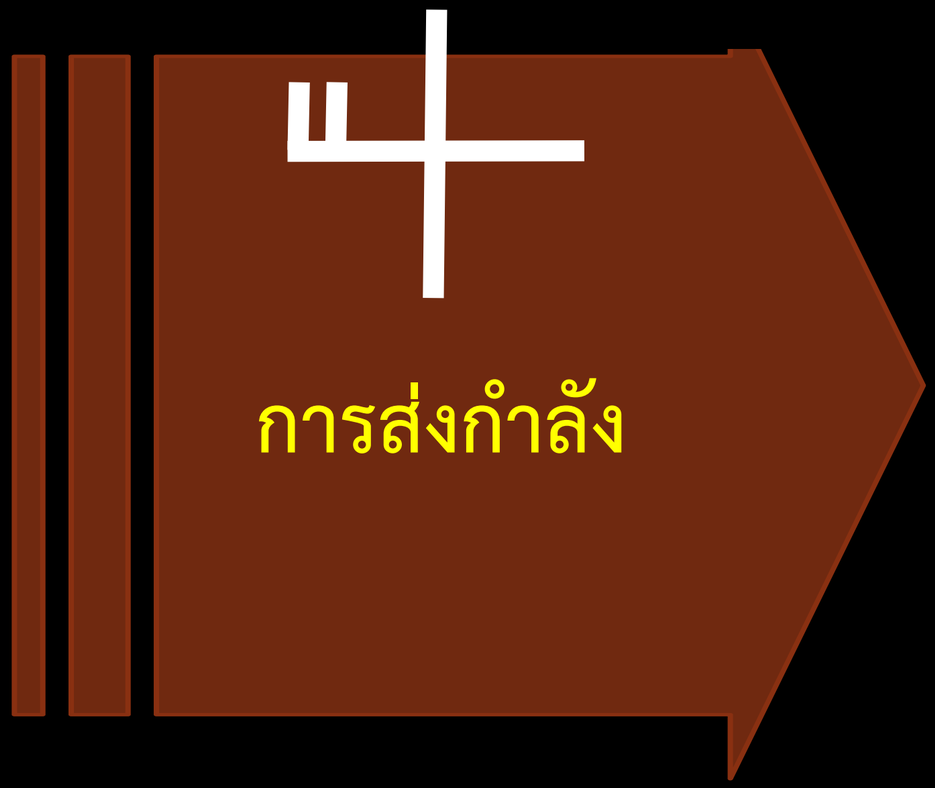
1. <u>ในสถานการณ์รบ</u>

- หลีกเลี่ยงการสะสม สป.ไว้เป็นจำนวนมาก
- คง สป.ให้เพียงพอ เพื่อเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่แพทย์ข้างหน้า

การขอ สป.สาย พ. เพิ่มเติมจาก
ที่พยาบาลกองพล
กระทำโดยอาศัยการส่งกลับ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของที่พยาบาลกองพัน



ก. สป.สาย พ.

1. <u>ในสถานการณ์รบ</u>

- การส่ง สป.สาย พ.ให้เจ้าหน้าที่แพทย์ข้างหน้า โดย รถยนต์พยาบาล, พวกเปล ฯลฯ
- การแลกเปลี่ยน สป.สาย พ. ที่สำคัญ
“ รายการต่อรายการ ”
(เปล เฝือก ผ้าห่ม สายรัดห้ามเลือด)
จำเป็นต้องกระทำทุกขั้นตอน
- รถยนต์พยาบาล บรรทุก สป.สาย พ. ไว้เพื่อทำการแลกเปลี่ยน

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

การส่งกำลัง

ก. สป.สาย พ.

1. ในสถานการณ์รบ

การเพิ่มเติม สป.สิ้นเปลืองสาย พ.

- ที่พยาบาลกองพัน จะเบิกอย่างไม่เป็นทางการไปยัง **ที่พยาบาลกองพลหน้า** โดยฝากไปกับพลขับรถยนต์พยาบาลของที่พยาบาลกองพลหน้า
- ในกรณีเร่งด่วน อาจร้องขอทางวิทยุ โทรศัพท์ ให้ ที่พยาบาลกองพล นำส่งโดย ฮ.

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

การส่งกำลัง

การส่งกำลังของหน่วยแพทย์ในสนาม

ที่พยาบาลกองพัน รับผิดชอบในการส่งกำลัง สป.สาย.พ.ให้กับนายสิบพยาบาลกองร้อย ที่อยู่ในแนวหน้า

ที่พยาบาลกองพล รับผิดชอบการส่งกำลัง สป.สาย.พ. ให้กับ ที่พยาบาลของหน่วยที่ไปให้การสนับสนุน เช่น ที่พยาบาลกองพัน ที่พยาบาลกรม

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

การส่งกำลัง

ก. สป.สาย พ.

2. นอกสถานการณ์รบ

วิธีส่งกำลังตามปกติโดยเสนอความต้องการ

ตามสายการบังคับบัญชา

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติงานของ ที่พยาบาลกองพัน

ที่พยาบาลกองร้อย
(COMPANY AID POST)

จัดตั้งโดยนายสิบพยาบาลกองร้อยอาวุโส
ที่ประจำอยู่ ณ ทก.ร้อยอาวุธเบา
เพื่อดำเนินการดังนี้

1. ให้การปัจจุบันพยาบาลแก่ ผป.เจ็บในพื้นที่ ทก.ร้อย.อวบ.
2. ตรวจดูความเรียบร้อยของบาดแผลที่ ส.พยาบาลกองร้อย มว.ปล.ได้ทำมาแล้วให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. เตรียมการส่งกลับ ผป.เจ็บไปยัง ที่พยาบาลกองพัน

ส.พยาบาลกองร้อย ตามอัตรามูลฐาน คือ “ 4 คน ต่อ 1 กองร้อย” (1 คน ต่อ 1 มว.ปล. และ 1 คนต่อ ทก.ร้อย.ฯ) หากมีกำลังพลพอ อาจบรรจุมอบให้ มว.อาวุธ อีกหนึ่งคนก็ได้

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

ที่พยาบาลกองร้อย
(COMPANY AID POST)

4. แจ้งสถานการณ์ทางการแพทย์ และการสุขาภิบาลให้ ผบ.ร้อย.อวบ. ทราบ
5. เสนอแนะวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาล ที่เหมาะสม
6. กำกับดูแลทางเทคนิคในการควบคุมพาหะนำโรค ต่าง ๆ
7. ประสานการปฏิบัติของนายสิบพยาบาลกองร้อย
8. ประสานการส่งกลับของรถยนต์พยาบาล และพวกเปล
9. แจ้งสถานการณ์ทางการแพทย์ให้นายแพทย์ พัน.ร. ทราบ โดยผ่าน
- ข่ายการสื่อสารของ ร้อย.อวบ.
- ทางสายการส่งกลับ

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ที่พยาบาลกองร้อย
(COMPANY AID POST)

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

นายสิบพยาบาลกองร้อย

- ประจำอยู่ มว.ปล.ร้อย.อวบ.
- กินอยู่หลับนอนร่วมทำการฝึก และร่วมทำการรบกับ มว.ปล.ร้อย.อวบ.
- ให้การปัจจุบันพยาบาลแก่กำลังพลที่ป่วย หรือ บาดเจ็บ

(เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์คนแรกที่ให้การปัจจุบันพยาบาลผู้ป่วยเจ็บใน แนวหน้า)

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ที่พยาบาลกองร้อย
(COMPANY AID POST)

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

ขีดความสามารถของนายสิบพยาบาลกองร้อย

เกี่ยวกับการปัจจุบันพยาบาล หรือเรียกว่าการดูแลรักษาโดยนายสิบพยาบาล (Aidman Care)

เพื่อช่วยชีวิตและสงวนแขน ขา ของผู้ป่วยเจ็บไว้

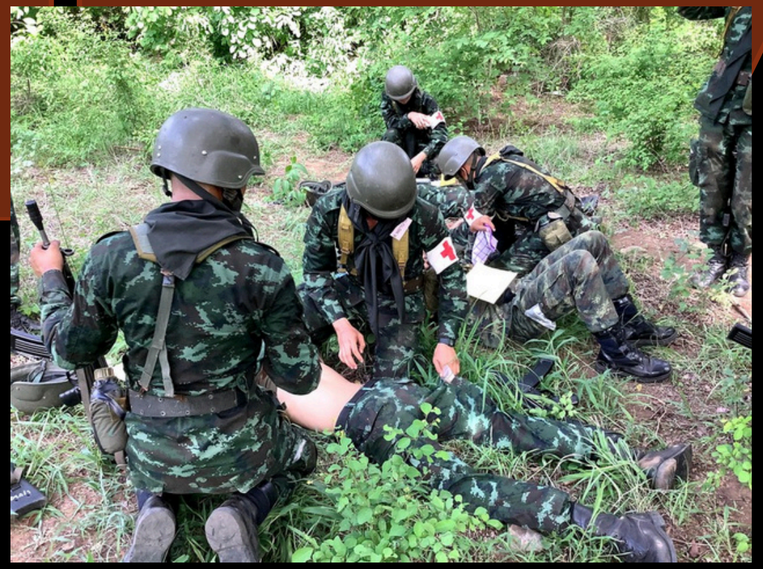
1. ห้ามเลือดโดยใช้ผ้าแต่งแผลกดทับ และใช้ผ้าพันแผลพันรัด (ใช้สายรัดห้ามเลือดเมื่อจำเป็น)
2. แก้ไขทางเดินหายใจโดยวิธีไม่ผ่าตัด เช่น เป่าปาก
3. การให้ของเหลวทางเส้นเลือดเมื่อจำเป็น

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

ขีดความสามารถของนายสิบพยาบาลกองร้อย

ที่พยาบาลกองร้อย
(COMPANY AID POST)



4. การแต่งแผลและการเข้าเฝือกชั่วคราว (เฝือกแสวงเครื่อง)
5. การทำให้ผู้ป่วยเจ็บสบายขึ้น เช่น การให้ยาบรรเทาปวด
6. เตรียมผู้ป่วยเจ็บเพื่อส่งกลับ และร้องขอการส่งกลับ
7. อื่น ๆ เช่น การเขียนบัตร พ.ส.1 (ทบ.466 - 901) ชี้ทางให้ ผป.เจ็บเดินได้ การเวชกรรมป้องกัน ฯลฯ

หน้าที่ในการปัจจุบันพยาบาลทหารผู้ป่วยเจ็บในสนามรบ และคัดแยกผู้บาดเจ็บตามลักษณะอาการ การรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสนามเป็นหน้าที่ของ นายสิบพยาบาลกองร้อย

การบริการทางการแพทย์

ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

ลำดับความเร่งด่วนของการรักษาบาดแผลในสนามรบ

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ
มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การส่งกลับต้องไม่เกิน ? นโยบายการส่งกลับ?

วิธีการส่งกลับ

1. การส่งกลับทางพื้นดิน

2. การส่งกลับทางอากาศ
   - เร่งด่วน สาหัส
   - ลมฟ้าอากาศ สถานการณ์ทางยุทธวิธี
   - จากแนวหน้าร้องขอการส่งกลับผ่านทางสายการบังคับบัญชา

3. การส่งกลับทางน้ำ

งานสายแพทย์ที่ “ยากลำบากที่สุด” ในสนามรบ คือ.... “การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ”

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

เครื่องมือการส่งกลับ

รถยนต์พยาบาล

รถยนต์พยาบาลในแนวหน้า จำนวน 3 คัน
จัดเป็น เครื่องมือส่งกลับหลัก

มีนายสิบพยาบาลประจำคันละ 1 นาย เพื่อดูแล ผป.เจ็บระหว่างทาง

รถยนต์พยาบาลในแนวหน้า 1 คัน
สามารถบรรทุกผู้ป่วยเจ็บนอนเปลได้ 4 คน
หรือนั่งได้ 8 คน (ฮั่มวี่ M-997)

การใช้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอันเนื่องมาจากสถานการณ์รบ
ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพลม ฟ้า อากาศ ในขณะนั้นด้วย

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

เครื่องมือการส่งกลับ

เปล

- ให้การปัจจุบันพยาบาล ผป.เจ็บระหว่างทาง
- ชี้ทางให้ ผป.เจ็บเดินได้ไปยังที่ พยาบาลกองร้อย หรือที่พยาบาลกองพัน
- ทำหน้าที่สื่อสารทางการแพทย์ ดำรงการติดต่อกับกำลังรบ
- ช่วยเคลื่อนย้ายที่พยาบาลกองพัน
- ช่วยส่งกำลัง สป.สาย พ.
- เขียนบัตรบันทึกการเจ็บป่วยในสนามตามความจำเป็น

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

เครื่องมือการส่งกลับ

รถสายพานลำเลียงพล

- ดัดแปลงเป็นรถพยาบาล ใช้ส่งกลับ ผป.เจ็บ
- แทนรถยนต์พยาบาล 1 ¼ ตัน
- ใช้ลำเลียง ผป.เจ็บ จากแนวหน้ามายังที่พยาบาลกองร้อย
- ใช้ลำเลียง ผป.เจ็บและ จนท.แพทย์
- ข้ามภูมิประเทศที่ยากลำบากและอันตราย
- เช่น ที่เปิดเผยต่อการยิงของข้าศึก
- อันตรายจากสะเก็ดระเบิดของลูก ป.และ ค.

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องนำมาวางแผน

1. แผนทางยุทธวิธีของผู้บังคับกองพัน หรือ ฝอ.3 เป็นหลัก (สำคัญที่สุด)
2. จำนวนผู้ป่วยเจ็บที่ได้ทำการประมาณการไว้
3. พื้นที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเจ็บมากที่สุด ที่ไหน เมื่อไร จึงจะเกิดผู้ป่วยเจ็บขึ้น
4. ความต้องการการส่งกลับ
5. สถานที่ตั้งที่รักษาพยาบาลที่ต้องการ

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

วางแผนโดยยึดหลักนิยม

6 ประการ

1. หลักความต่อเนื่อง
2. หลักการควบคุม
3. หลักความใกล้ชิด
4. หลักความอ่อนตัว
5. หลักความคล่องตัว
6. หลักความสอดคล้อง

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

สายการ
บังคับบัญชา

ผบ.ร้อย.สสช.พัน.ร.

รับผิดชอบต่อ มว.สร.ฯ ทุกเรื่องเกี่ยวกับ

- การบังคับบัญชา
- การฝึกทางยุทธวิธี เว้น การฝึกทางเทคนิค
- การธุรการและกำลังพล
- การเลี้ยงดู
- การส่งกำลัง

การบริการทางการแพทย์

ระดับหน่วย

สายการ
บังคับบัญชา
ใน พัน.ร.

การปฏิบัติของ
มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

ความเหนื่อยล้าจากการรบ

COMBAT EXHAUSTION

อาการ

1. กล้ามเนื้อเกร็งตัวมากขึ้น
2. ตัวสั่น
3. เหงื่อออก
4. เบื่ออาหาร
5. ชีพจรเร็ว

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

ความเหนื่อยล้าจากการรบ
COMBAT EXHAUSTION

พฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้น
แบ่งออกเป็น 3 พวก

1. พวกเป็นอย่างอ่อน
2. พวกเป็นปานกลาง
3. พวกเป็นอย่างรุนแรง

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

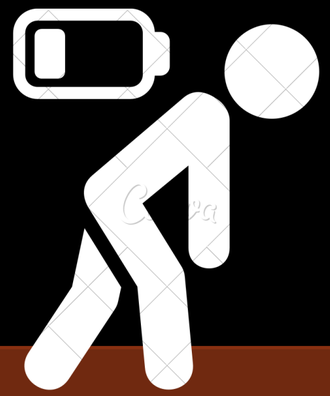
ความเหนื่อยล้าจากการรบ
COMBAT EXHAUSTION

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

การดูแลรักษา ณ ที่พยาบาลกองพัน

1. การรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยเจ็บอื่น ๆ
2. จะต้องรักษาตั้งแต่ข้างหน้าสุดเท่าที่จะทำได้
3. การนำผู้ป่วยเจ็บไปยังพื้นที่ส่วนหลังจะทำให้มีอาการมากขึ้น เว้นพวกเป็นอย่างรุนแรง
4. การให้ยา Sedative ขนาดมากเกินไปจะทำให้มีอาการมากขึ้น และป่วยอยู่นานมากขึ้น

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.



ความเหนื่อยล้าจากการรบ
COMBAT EXHAUSTION

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

5. วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้พักผ่อน การทำให้อบอุ่นใจ
6. การทำให้ผู้ป่วยเจ็บฟื้นคืนสภาพเป็นปกติได้จะเป็นผลดีกับผู้ป่วยเองและหน่วย
7. ผบ.มว.สร. ในฐานะนายแพทย์ ไม่จำเป็นต้องเป็นจิตแพทย์ก็พอรักษาได้ นายสิบพยาบาลจะต้องรู้จักอาการและดูแลผู้ป่วยเจ็บได้

อย่าเขียนระบุด้วยคำที่แสดงว่าผู้ป่วย *“วิกลจริต”*

การบริการทางการแพทย์
ระดับหน่วย

การปฏิบัติของ มว.สร..ร้อย.สสช.พัน.ร.

การปฏิบัติของ ที่พยาบาลกองพัน

- สรรพาวุธ กระสุนและ ลูกระเบิดขว้าง/ยิง เก็บไว้ที่ **ที่พยาบาลกองพัน**

อาวุธประจำกาย (ปืน,ดาบปลายปืน) เก็บไว้ที่ **ที่พยาบาลกองพล**

- ยุทธภัณฑ์อื่น ๆ ผบ.พล ร., หน่วยเหนือ หรือ ผู้มีอำนาจอื่น ๆ กำหนด จะเก็บไว้ที่ **ที่พยาบาลกองพล** เว้นเครื่องใช้ในการบริโภค หมวกเหล็ก ของใช้ส่วนตัว จะติดตัวผู้ป่วยเจ็บไปข้างหลัง

พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์

เพื่อบรรลุภารกิจ เหล่า พ. มีพันธกิจสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

4

1 การเวชกรรมป้องกัน

ป้องกันการเกิดโรค การทำให้ชีวิตยืนยาว
และการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต

2 การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ

การดูแลรักษาพยาบาลในหน่วยแพทย์ต่าง ๆ
ตั้งแต่รับตัวรักษาจนจำหน่าย

3 การส่งกำลัง สป. สาย พ.

สนับสนุน สป.สาย พ.
อย่างพอเพียงและทันเวลา

4 การบริการแพทย์อื่นๆ

- การทันตกรรม
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ธนาคารเลือด

สิ่งที่รู้จัก

ยากที่สุด

คือ...

"ตัวเราเอง"

-พุทธทาสภิกขุ